



100004



发文日：

2024 年 08 月 05 日

申请号或专利号：202080004041.1

发文序号：2024073102065930

案件编号：4W117264

发明创造名称：用于治疗抑郁症的右美沙芬和安非他酮的组合

专利权人：安泰赛普生物风投二代有限责任公司

无效宣告请求人：刘荣

无效宣告请求审查决定书

(第 569133 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☒宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 11 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：潘珂

主审员：刘琳

参审员：孔佳音



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 569133 号)

案件编号	第 4W117264 号
决定日	2024 年 07 月 29 日
发明创造名称	用于治疗抑郁症的右美沙芬和安非他酮的组合
国际主分类号	A61K 31/137
无效宣告请求人	刘荣
专利权人	安泰赛普生物风投二代有限责任公司
专利号	202080004041.1
申请日	2020 年 01 月 07 日
优先权日	2019 年 01 月 07 日
授权公告日	2022 年 04 月 12 日
无效宣告请求日	2023 年 12 月 15 日
法律依据	专利法第 22 条第 2 款
决定要点：在进行新颖性判断时，首先应当判断被审查专利要求保护的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同，如果专利要求保护的技术方案与对比文件公开的技术方案相比不能够相区分，二者实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明。	

一、案由

涉案专利的专利号为 202080004041.1，优先权日为 2019 年 01 月 07 日，申请日为 2020 年 01 月 07 日，授权公告日为 2022 年 04 月 12 日。涉案专利授权公告的权利要求书如下：

“1.包含 45 mg 的右美沙芬和 105 mg 的安非他酮的组合在制造快速缓解抑郁症的症状的药物中的用途。”

请求人于 2023 年 12 月 15 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其理由是：权利要求 1 保护范围不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性；权利要求 1 不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，请求宣告涉案专利全部无效，同时提交了涉案专利授权公告文本和如下证据的打印件：

证据 1：公开号为 US2016/0339017A1 的美国发明专利申请的公开文本；

证据 2：公开号为 US2017/0354619A1 的美国发明专利申请的公开文本；

证据 3：公开号为 CN106163522A 的中国发明专利申请的公开文本。

请求人认为：（1）权利要求 1 中的特征“快速缓解”在本领域没有确切的含义，本领域技术人员不知晓何种缓解抑郁症症状的速率可以被称为“快速缓解”，也不知道所述快速缓解究竟为多快速，导致权利要求 1 的保护范围不清楚。（2）证据 1 公开了包含所述 45mg 的右美沙芬和约 105mg 安非它酮的复方制剂用于治疗抑郁症，而“快速缓解”属于效果限定，并未将权利要求 1 中的疾病种类与证据 1 区分开，因此权利要求 1 相对于证据 1 而言不具新颖性；基于类似的理由，权利要求 1 相对于证据 2 而言也不具备新颖性。（3）即使认为“快速缓解”构成权利要求 1 与证据 1 的区别特征，证据 1 的说明书也公开了右美沙芬和安非它酮共同施用能够起到快速治疗抑郁症的作用，权利要求 1 相对于证据 1 而言不具备创造性。即使认为证据 2 只公开了所述剂型而未公开制药用途，证据 2 的说明书或证据 3 也已经公开了右美沙芬和安非它酮共同施用能够起到快速治疗抑郁症的作用，权利要求 1 相对于证据 2 或证据 2 与证据 3 的组合而言不具备创造性。权利要求 1 与证据 3 的区别在于如何在证据 3 的基础上选择具体的右美沙芬和安非它酮的剂量，在证据 3 说明书或证据 1/2 的启示下，可以得到选择权利要求 1 保护的技术方案的启示，权利要求 1 相对于证据 3 或证据 3 与证据 1/2 的组合不具备创造性。

请求人于 2024 年 01 月 09 日提交了复审无效宣告程序补正书及附件，附件中提供了证据 1-2 及其中文译文。

请求人于 2024 年 01 月 12 日再次提交了意见陈述书、证据 1-3 及证据 1-2 的中文译文，重申了复审请求书中的意见。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2024 年 01 月 15 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书、补正书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2024 年 02 月 18 日提交了意见陈述书、修改后的权利要求书（共 1 项）

以及反证 1-7 的电子件，反证 1-7 如下：

反证 1: Joseph F. Goldber 等, Addressing the unmet needs of current antidepressants: does neuroscience help or hinder clinical psychopharmacology research?, “Expert Opinion on Pharmacotherapy”, 第 18 卷第 14 期, 在线发布时间: 2017 年 08 月 11 日, 第 1417-1420 页;

反证 1A: 反证 1 的中文译文;

反证 2: Nofziger Jill L 等, Evaluation of dextromethorphan with select antidepressant therapy for the treatment of depression in the acute care psychiatric setting, “Mental Health Clinician”, 第 9 卷第 2 期, 2019 年, 第 76-81 页; 反证 2A: 反证 2 的中文译文;

反证 3: Edward C. Lauterbach, Dextromethorphan as a potential rapid-acting antidepressant, “Medical Hypotheses”, 第 76 卷, 2011 年, 第 717-719 页;

反证 3A: 反证 3 的中文译文;

反证 4: James W. Murrough 等, Dextromethorphan/quinidine pharmacotherapy in patients with treatment resistant depression: A proof of concept clinical trial, “Journal of Affective Disorders”, 第 218 卷, 2017 年, 第 277-283 页;

反证 4A: 反证 4 的中文译文;

反证 5: CENTER FOR DRUG EVALUATION AND RESEARCH, MULTI-DISCIPLINE REVIEW, NDA/BLA Multidisciplinary Review and Evaluation, Application Number: 215430Orig1s000, 2021 年 02 月提交;

反证 5A: 反证 5 的部分中文译文;

反证 6: NICK ZAGORSKI, FDA Approves Rapid-Acting Oral Antidepressant, Psychiatric News, “Clinical & Research”, 2022 年 10 月 24 日;

反证 6A: 反证 6 的中文译文;

反证 7: Laura E. Pope 等, Pharmacokinetics of Dextromethorphan After Single or Multiple Dosing in Combination With Quinidine in Extensive and Poor Metabolizers, “Journal of Clinical Pharmacology”, 第 44 期, 2004 年, 第 1132-1142 页;

反证 7A: 反证 7 的中文译文。

专利权人认为：对权利要求书的修改符合专利审查指南对无效阶段修改的相关规定，假如修改后的权利要求 1 因违反相关规定而不能被接受，则请基于授权公告的权利要求 1 进行审理，无论是针对修改前还是修改后的权利要求 1，（1）权利要求 1 清楚，符合专利法第 26 条第 4 款的规定。在抑郁症领域，快速缓解具有普遍公认的含义。并且涉案专利说明书也给出了该特征的明确含义，涉案专利权利要求 1 中的“快速缓解”应当理解为人在施用安非他酮和右美沙芬的所述组合的第一天的 2 周内经历治疗效应。（2）无论是证据 1 还是证据 2 都没有公开“快速缓解”特征，更没有公开人在施用安非他酮和右美沙芬的所述组合的第一天的 2

周内经历治疗效应。根据涉案专利说明书和反证 1，“快速缓解”在抑郁症治疗中涉及一类特定的疾病，或者代表了“治疗抑郁症”这一宽泛概念中的一种具体的下位概念，因此能够与证据 1 或证据 2 相区别，权利要求 1 相对于证据 1 或 2 而言具备新颖性。（3）同样的，证据 1-3 也没有教导如何实现抑郁症症状的“快速缓解”，更没有教导人在施用安非他酮和右美沙芬的所述组合的第一天的 2 周内经历治疗效应，反证 1-7 证明涉案专利提出时本领域对于抗抑郁药物的研发现状，可以阐明抑郁症领域的复杂性和药物研发所面临的巨大困难。而涉案专利描述的临床研究证明了所要求保护的组合解决了如何更快地缓解抑郁症的症状的技术问题，其效果是本领域技术人员预料不到的。因此权利要求 1 相对于证据 1-3 及其任意组合方式而言具备创造性。

修改后的权利要求书为：

“1.包含 45mg 的右美沙芬和 105 mg 的安非他酮的组合在制造快速缓解抑郁症的症状的药物中的用途，其中人在施用安非他酮和右美沙芬的所述组合的第一天的 2 周内经历治疗效应。”

专利权人于 2024 年 02 月 19 日再次提交了意见陈述，重申了其在 2024 年 02 月 18 日提交的意见陈述中的理由。

合议组于 2024 年 02 月 22 日将专利权人于 2024 年 02 月 18 日提交的意见陈述书、反证 1-7，2024 年 02 月 19 日提交的意见陈述书的副本转送给请求人，并于 2024 年 03 月 08 日将请求人于 2024 年 01 月 12 日提交的意见陈述书、证据 1-3 及其中文译文的副本转送给专利权人。

国家知识产权局本案合议组于 2024 年 04 月 09 日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于 2024 年 05 月 24 日举行口头审理。

专利权人于 2024 年 05 月 15 日提交了意见陈述书：（1）强调了根据本申请说明书，由实施例 3 和实施例 6、图 14、图 17 本领域普通技术人员会直接且毫无疑问地确定“快速缓解抑郁症的症状”意味着“人在施用安非他酮和右美沙芬的所述组合的第一天的 2 周内经历治疗效应。”，反证 5 也佐证了这一点。因此，权利要求 1 和修改后的权利要求 1 均是清楚的。（2）重申了权利要求 1 相对于证据 1 或证据 2 具备新颖性。（3）主张权利要求 1 相对于证据 1 或证据 2 或者证据 3 实际解决的技术问题是如何在没有与氯胺酮等药物相关的不希望的副作用的情况下更快速地缓解抑郁症的症状。反证 1-7 表明了抑郁症治疗机理的复杂性以及在涉案专利之前的现有技术未实现快速缓解的目标。无论是证据 1 或者证据 2 或证据 3，均没有给出解决该技术问题的技术启示。而涉案专利已经证明了其请求保护的技术方案能够取得预料不到的技术效果。因此，涉案专利权利要求 1 具备创造性。

合议组于 2024 年 05 月 21 日将专利权人的上述意见陈述转送给请求人。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，记录了如下事项：

（1）合议组告知双方当事人，专利权人于 2024 年 02 月 18 日提交的权利要求书的修改方式不属于专利

法实施细则和审查指南规定的允许修改的情形，因此不予接受，本案的审查文本是涉案专利的授权公开文本，双方就此均未提出异议。

（2）请求人明确无效宣告理由为：权利要求 1 不清楚，不符合专利法第 26 条第 4 款规定；权利要求 1 不具备新颖性，不符合专利法第 22 条第 2 款的规定；权利要求 1 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

（3）请求人当庭提交了证据 4（精神障碍诊疗规范（2020 年版），国家卫生健康委发布，公开日为 2020 年 11 月）原件作为公知常识性证据，证明“快速缓解抑郁症”并非抑郁症的具体分型之一，合议组当庭转送专利权人。

（4）专利权人对证据 1-3、当庭提交的公知常识证据（证据 4）的真实性无异议，但主张其当庭提交的证据的公开日期在涉案专利的申请日之后，因此不属于申请日前的公知常识。专利权人对于证据 1-2 的译文准确性无异议。请求人对于反证 1-4、6-7 的真实性无异议，不认可反证 5 的真实性、公开性、合法性，主张反证 2、5、6 的公开日在涉案专利申请日之后，不认可反证 1-7 的关联性。请求人对于反证 1-7 的译文准确性无异议。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1. 审查基础

专利权人在 2024 年 02 月 18 日提交了修改的权利要求，所作修改为根据涉案专利授权公告文本说明书的第【0094】段、【0143】段、【0642】段、【0644】段，在授权公告的权利要求 1 中补入技术特征“其中人在施用安非它酮和右美沙芬的所述组合的第一天的 2 周内经历治疗效应”。

发明专利的说明书与权利要求书的法律地位和作用不同，对于授权公告的发明专利而言，权利要求书是社会公众明确专利保护范围的法律基础。无效程序中对权利要求书的修改，一方面是为了方便专利权人针对无效理由来以更灵活的方式进行应对，通过修改将发明对现有技术做出贡献的技术特征限定到权利要求中，从而使其权利更稳定，另一方面出于维护授权专利权利要求公示作用、平衡专利权人权利和社会公众的利益等方面的考虑，还需要保障社会公众基于授权公告的权利要求书能够对专利权人的修改做出合理预期。如果允许专利权人在无效宣告程序中将原来仅仅记载在说明书中的技术特征补入到权利要求中，则会损害社会公众对专利文件修改的可预期性。因此，专利法实施细则第六十九条以及专利审查指南第四部分第三章 4.6 节无效宣告程序中对发明专利无效阶段修改原则、修改方式及其限制作出规定。根据专利审查指南的相关规定，发明专利文件的修改仅限于权利要求书，修改原则之一即为一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。在满足修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。专利权人在 2024 年 02 月 28 日提交的权利要求书的修改方式显然不符合上述修改原则，也不属于上述具体修改方式的任何一种，因此该修改不能够被接受。

因此，本案的审查基础为授权公告文本。

2.证据认定

证据 1 为美国专利申请文件的公开文本，专利权人对其真实性、公开性无异议。经核实，合议组认可其真实性，其公开时间为 2016 年 11 月 24 日，在涉案专利优先权日之前，因此可以作为涉案专利的现有技术。专利权人对证据 1 的译文准确性无异议，在此基础上，合议组认可证据 1 的译文准确性。

对于反证 1-7 而言，经核实，请求人对反证 1-4、6-7 的真实性和公开时间无异议，但主张反证 2、6 的公开时间在涉案专利的申请日之后，不属于现有技术；不认可反证 5 的真实性、公开性；不认可反证 1-7 与涉案专利的关联性。

反证 1-4、7 为杂志期刊文献，反证 5-6 为网页证据，在请求人对反证 1-4、6-7 的真实性和公开时间无异议的前提下，合议组对其真实性和公开性予以认可。同时，经合议组核实，反证 1，反证 3，反证 4 和反证 7 公开时间在涉案专利优先权日前，构成现有技术，可以用于证明涉案专利优先权日当时的技术水平，反证 2、6 的公开时间在涉案专利优先权日之后，不属于现有技术，其能否达到专利权人主张的证明目的，下文将结合具体事实进行认定。反证 5 是申请号为 2015430Orig1s000 的 NDA/BLA 多学科评审和评价，专利权人当庭通过输入网址找到了该篇文献，但当庭通过网址验证的网页信息与反证 5 的电子件显示不一致，专利权人承认无法通过关键词输入的方式查找到该篇网页信息。

合议组认为：当事人对自己提出的无效宣告请求所依据的事实或者反驳对方无效宣告请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。鉴于专利权人无法证实反证 5 的合法来源和真实性，同时，反证 5 的公开时间也在涉案专利优先权日之后，不属于现有技术，也难以反映涉案专利最早优先权日时的现有技术状况，因而专利权人依据反证 5 主张的事项不能被认可。

3.专利法第 22 条第 2 款

专利法第 22 条第 2 款规定：新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。

在进行新颖性判断时，首先应当判断被审查专利要求保护的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同，如果专利要求保护的技术方案与对比文件公开的技术方案相比不能够相区分，二者实质上相同，所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，则认为两者为同样的发明。

权利要求 1 请求保护包含 45 mg 的右美沙芬和 105 mg 的安非他酮的组合在制造快速缓解抑郁症的症状的药物中的用途。

请求人主张：证据 1 公开了包含所述 45mg 的右美沙芬和约 105mg 安非它酮的复方制剂用于治疗抑郁症，

而“快速缓解”属于效果限定，并未将权利要求 1 中的疾病种类与证据 1 区分开，因此权利要求 1 相对于证据 1 而言不具新颖性。

专利权人在意见陈述书和口审时均主张，根据本领域普遍含义以及涉案专利授权文本第【0094】段、【0143】段、【0642】段、【0644】段以及实施例 3 和实施例 6 的记载，对于权利要求 1 中的快速缓解应当理解为“人在施用安非它酮和右美沙芬的所述组合的第一天的 2 周内经历治疗效应”。同时反证 5 的临床研究也表明，MADRS 总分降低 6 分至 9 分被认为对 MDD（重度抑郁症）患者具有临床意义，从涉案专利的图 13 和图 15 中可以清楚地看到，施用 DM+BU 的受试者在 2 周内经历了 MADRS 总分从基线降低 ≥ 9 分，这表明：抑郁症的症状在临床意义上毫无疑问地显著改善，佐证了上述观点。证据 1 没有公开涉案专利权利要求 1 所保护的技术方案，尤其没有公开“快速缓解”特征，更没有公开“人在施用安非他酮和右美沙芬的所述组合的第一天的 2 周内经历治疗效应。”而根据涉案专利的说明书和现有技术（例如反证 1）可知：在涉案专利申请之时，抑郁症的治疗涉及非常宽泛种类的疾病，但“快速缓解抑郁症的症状”仅仅代表了“治疗抑郁症”这一宽泛概念中的其中一种具体的下位概念。反证 1-7 表明了抑郁症治疗机理的复杂性以及在涉案专利之前的现有技术未实现快速缓解的目标。证据 1 完全没有公开或教导“快速缓解抑郁症的症状”，因此权利要求 1 相对于证据 1 具备新颖性。

经核实，证据 1 公开了：一种提高安非它酮治疗抑郁症疗效的方法，包括向患有抑郁症的人给予约 40 毫克至约 55 毫克的右美沙芬与约 100 毫克至约 110 毫克的安非它酮口服共同施用，每天两次，持续至少五周，其中该方法比通过每天两次单独口服给予该人 150 毫克的安非它酮持续 5 周的治疗抑郁症的方法更有效；其中约 45 毫克的右美沙芬和约 105 毫克的安非它酮一起存在于单一剂型中以每天两次给药（参见权利要求 14、19）。

由此可见，证据 1 已经公开了 45 毫克的右美沙芬和 105 毫克的安非它酮的组合制备为单一剂型药物及其在治疗抑郁症中的应用，权利要求 1 与证据 1 相比，进一步公开了该组合具有“快速缓解”抑郁症的症状中的应用。权利要求 1 是否具备新颖性的关键在于判断“快速缓解”是否构成区别技术特征。

对此，合议组认为：首先，无论快速缓解的定义是否如专利权人所言，为“人在施用安非它酮和右美沙芬的所述组合的第一天的 2 周内经历治疗效应”，都不属于现有技术中抑郁症的具体分型。目前的证据和反证 1-7 均未表明“快速缓解抑郁症的症状”或“人在施用安非它酮和右美沙芬的所述组合的第一天的 2 周内经历治疗效应”为抑郁症的常规分类或疾病亚型。而根据本领域的一般理解，“快速缓解抑郁症的症状”或“人在施用安非它酮和右美沙芬的所述组合的第一天的 2 周内经历治疗效应”是对抑郁症具体治疗效果的描述，针对的疾病还是抑郁症，因此不能与证据 1 公开的一般性的抑郁症相区分。

其次，结合涉案专利记载的内容，也不能将涉案专利与证据 1 相区别。

涉案专利提供了右美沙芬和安非它酮的组合在治疗抑郁症的应用，通过将二者联用，可以增加右美沙芬血浆水平和代谢寿命，减弱右美沙芬谷效应，降低右啡烷（右美沙芬代谢产物）的血浆水平，减少与右美沙

芬治疗相关的不良事件，改善安非它酮在治疗抑郁症中的治疗效应；一些实施方式包括快速缓解抑郁症的症状的方法，所述方法包括每天一次或两次向有需要的人施用右美沙芬，其中该人在施用安非它酮和右美沙芬的所述组合的第一天的2周内经历治疗效应；施用安非它酮与右美沙芬的组合可导致快速治疗效应，例如在开始治疗的约1周内、约2周内、约3周内或4周内的快速治疗效应（参见说明书发明内容部分以及说明书第0143段）。

涉案专利实施例1测定了安非它酮对右美沙芬8天中血浆浓度的影响，实施例2测定了各种抗抑郁剂化合物抑制人肝微粒体中右美沙芬代谢的效力，结果表明与施用单独的右美沙芬相比，在第8天时，安非他酮连同右美沙芬的施用分别导致平均右美沙芬的血浆浓度显著增加、 T_{max} 和消除半衰期($T_{1/2el}$)显著增加、右啡烷的血浆浓度显著降低；同时，安非它酮能够抑制右美沙芬代谢（参见表2-4）。但涉案专利的试验对象、试验方法、试验结果与证据1实施例1-2的记载几乎完全相同，仅在文字表述上略有差异，即涉案专利实施例1-2已经在事实上被证据1所公开。

涉案专利实施例3和实施例6分别考察了2期临床实验和3期临床试验中右美沙芬和安非它酮/右美沙芬组合对受试者的作用，其主要终点为6周时段内 MADRS 总评分的变化(经平均的)以及第6周时 MADRS 总评分的变化，结果通过变化值及 P 值进行表征；次要终点指标包括第1周至第2周的 MADRS 总评分变化、在第2周实现 MADRS 缓解的百分比、在第6周实现 MADRS 缓解的百分比、第6周时的 MADRS-6 变化、第6周时 MADRS-6 响应者的百分比、第1周时的临床总体印象-改善量表 (CGI-I)、第6周时的 CGI-I、第6周时的总体印象-严重度量表 (CGI-S)，结果通过与安非它酮比较的 P 值进行表征。并具体公开了：即使在治疗的第一周，与单独的 BU 相比，使用 DM 与 BU 的组合也使 MADRS 总评分(抑郁评级量表)显著降低。在第6周，与单独的安非他酮相比，DM/BU 组合的施用使 MADRS 总评分降低了约 42%；即使早在治疗的第二周，DM/BU 组合的缓解率也显著高于单独的对比物 BU 的缓解率(约 8 倍)，其中缓解率高出约 20%。在治疗的第6周，组合 DM/BU 的施用导致缓解率比单独的对比物 BU 高约 30%（参见说明书第 0741-0742 段记载）。在第6周与安慰剂相比，DM/BU 表现出蒙哥马利-阿斯伯格抑郁量表(MADRS)总评分的高度统计学上显著的降低，其中对于 DM/BU 来说相对于基线平均降低了 16.6 分，并且对于安慰剂来说相对于基线平均降低了 11.9 分($p=0.002$)。另外，在每天两次给药开始后的第1周或仅第4天观察到了统计学上显著的改善；在第6周观察到接受 DM/BU 的患者中有 54.0% 有响应(定义为 MADRS 总评分改善 $\geq 50\%$)，相比之下接受安慰剂的患者中有 34.0% 有响应($p<0.001$)。如图 17 所示，DM/BU 在第2周($p=0.013$)和之后的每个时间点(例如第3周、第4周、或第6周)的抑郁症缓解率(定义为 MADRS ≤ 10)均与安慰剂相比在统计学上显著更大，其中在第6周时有 39.5% 的 DM/BU 患者实现了抑郁症缓解，相比之下 17.3% 的安慰剂患者实现了抑郁症缓解($p<0.001$)。如通过希恩残疾量表(SDS)所测量的，DM/BU 也同在第2周($p=0.003$)和之后的每个时间点($p=0.002$ ，在第6周)与安慰剂相比功能损伤的统计学上显著减少相关联。在包括以下项在内的所有次要终点方面，与安慰剂相比，DM/BU 在第6周表现出了统计学上显著的改善，反映出随着时间推移不断增

加的治疗效应：对 MADRS 总评分的临床响应(定义为 $\geq 50\%$)($p < 0.001$)；PGI-1($p = 0.007$)；CGI-S($p = 0.002$)；CGI-I($p = 0.016$)；QIDS-SR-16($p = 0.001$)；希恩残疾量表(SDS)($p = 0.002$)；和 Q-LES-Q-SF($p = 0.011$)（参见说明书第 0773-0779 段）。

由上述结果可知，实施例 3 和实施例 6 的主要终点为第 6 周的测定结果，次要终点中则涵盖了第 1、2、6 周的测定结果，但并没有记载上述时间的选择具有何种临床意义以证明其能够成为区别于其它抑郁症的独立的疾病亚型。对于专利权人特地强调的实现 2 周内的治疗效应而言，合议组认为实验结果能够证明在第 2 周时 DM/BU（右美沙芬/安非它酮）较 BU（安非它酮）或安慰剂而言生物 MADRS 缓解百分比具有显著性的差异，但同时，实验结果也表明，在第 1 周同样观察到 MADRS 总评分的统计学上的显著改善（参见第 0774 段），而第 6 周相对于第 2 周则提供了更多的次要终点衡量指标（例如 MADRS-6、CGI-I、CGI-S）的改善，在提供了多个临床终点情况下，也无法得出第 2 周属于抑郁症具有临床治疗意义的节点的结论。

况且，即使考虑涉案专利权利要求 1 中快速缓解的内容，证据 1 也已经对其进行了公开。例如，证据 1 说明书中具体描述了其权利要求要求保护的技术方案所能够解决的技术问题和达到的技术效果，证据 1 说明书明确公开了右美沙芬与安非他酮对许多个体的抗抑郁特性，包括更快的起效（参证证据 1 说明书第 0221 段译文）。即证据 1 已经公开了右美沙芬/安非它酮的组合用于抑郁症治疗的快速起效，事实上本申请实施例 3 和 6 只是对证据 1 公开的上述结论进行了实验验证。

最后，专利权人提供反证 1-7 用于证明涉案专利与证据 1 属于不同种类的疾病，对此合议组认为：

（1）对于反证 1 和反证 5

反证 1 公开了“除了基本的药物治疗或心理治疗决策之外，“重度抑郁症”这个宽泛的类别传达的信息极少”（参见反证 1 第 1418 页第 3 段译文）。

考虑反证 5 电子件内容，则反证 5 公开了“大多数抗抑郁药需要长达 8 到 12 周的治疗，患者才能获得最大的改善”以及“MADRS 总分降低 6 至 9 分对 MDD 患者具有临床意义”（参见反证 5 第 13 页第 3 段、103 页倒数第 2 段译文）。

反证 1 尽管公开了重度抑郁症类别宽泛，但反证 1 并未公开“快速缓解”抑郁症。事实上，反证 1 关注点在于如何满足患有合并精神、药学或物质使用障碍的抑郁症患者、单一用药或两药联合效果不佳患者的用药需求，而不涉及对其治疗起效时间考虑。因此，反证 1 不能证明“快速缓解”属于特定疾病亚型，也不能证明涉案专利具有新颖性。

对于反证 5 而言，如前所述，其真实性存疑，退一步而言，即使认可其真实性，其提交日期为 2021 年 02 月 21 日，并不能够反映涉案专利最早优先权日时的现有技术状况。更何况，即使对于反证 5 公开内容进行考虑，反证 5 也并未说明抑郁症能够依靠治疗时长分为不同的类型，也不能说明快速缓解具体指代的是哪种抑郁症，同时涉案专利也不涉及对患者获得“最大的改善”的治疗时长的研究。此外，MADRS 总分 6 至 9 分也不代表药物必然能够具有治疗作用，例如涉案专利第 0774 段记载了对于安慰剂来说相对于基线平均降低了

11.9 分，即即使不给药，MADRS 也可能达到 6 分或更高。因此，反证 5 不能证明涉案专利具有新颖性。

（2）对于反证 2-4、6-7 而言，首先专利权人并未将其用于证明涉案专利具备新颖性，不应予以考虑。退一步而言，即使对其公开内容进行考虑，也不能证明涉案专利权利要求 1 具有新颖性。

经核实，反证 2-4、6-7 公开内容如下：

反证 2：公开了“对右美沙芬联合选择性抗抑郁疗法在急性神经病护理环境中治疗抑郁症的评价”，“右美沙芬与快速抗抑郁效应无关。常用的每天 30mg 的剂量可能太低而没有效应”（参见反证 2 标题、摘要译文）

反证 3：公开了“最近，N-甲基-邻天冬氨酸（NMDA）谷氨酸受体拮抗剂氯胺酮在临床试验中被证明介导快速抗抑郁作用”，并且“NMDA 拮抗剂右美沙芬和氯胺酮之间的药效动力学比较表明了以下假说：右美沙芬临床试验可 25 能显示出相似的抗抑郁功效”（参见反证 3 第 718 页引言第 1 段、第 3 段译文）。

反证 4：公开了“本研究是一项检查右美沙芬（DM）和 CYP2D6 酶抑制剂奎尼丁（Q）的组合对 TRD 患者的功效和耐受性的 IIa 期开放标签临床试验”；“在合并服用抗抑郁药物和未合并服用抗抑郁药物的患者之间，以及在中等难治性和高难治性患者之间，改善程度类似”（参见反证 4 摘要、讨论部分第 1 段译文）。

反证 6：FDA 批准了速效口服抗抑郁药 Auvelity（右美沙芬/安非它酮缓释片剂）；Murrough 阐述道：“已经有许多高品质的精神病学研究试图通过结合两种应该彼此互补的药物来 15 实现治疗协同作用”，并且“直到最近，结果通常都令人失望”（参见反证 6 全文译文）。

反证 7：30mg 右美沙芬和 30mg 奎尼丁的组合在第一天就可提高血浆中右美沙芬的 AUC（参见表 IV 译文）。

首先，反证 2、6 的公开时间在涉案专利的优先权日之后，不能够代表优先权日时的现有技术状况。其次，即使考虑其公开内容，反证 2-4、6-7 均未公开快速缓解抑郁症属于抑郁症特定分型或能够与其他种类的抑郁症相区分。反证 2 公开了“右美沙芬与快速抗抑郁效应无关”，但其同时也公开了“本研究中利用的剂量很可能低于治疗剂量并且无法产生抗抑郁活性”，即其治疗效果不佳与右美沙芬的剂量不足有关，因此反证 2 并未给出右美沙芬不能快速抗抑郁的反向教导。反证 3-4、6-7 至多能够证明抑郁症治疗机制的复杂性，也未说明涉案专利与证据 1 中右美沙芬和安非它酮的组合针对的抑郁症是不同种类的抑郁症，因此仍不能表明涉案专利能够与证据 1 公开的疾病相区分。

综上，反证 1-7 也不能证明涉案专利权利要求 1 相对于证据 1 针对不同疾病。

因此，上述证据和事实均表明“快速缓解”的限定不能使得涉案专利与证据 1 的疾病种类产生区别。同时，也没有证据表明所述限定能够使得制备得到药物产生区别。在二者技术领域和技术方案均相同、且解决了相同的技术问题、产生了相同的技术效果的情况下，权利要求 1 相对于证据 1 不具备新颖性。

鉴于已经得出全部无效的结论，对请求书中涉及的其它无效请求理由和证据不再进行评述。

基于以上事实和理由，合议组作出如下决定。

三、决定

宣告 202080004041.1 号发明专利权全部无效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：潘珂
主审员：刘琳
参审员：孔佳音

